

Plan *bezpieczeństwa*

Pierwsze tygodnie po wypisie i moment wglądu — okresy podwyższonego ryzyka. Karta z planem działania na trudne chwile. Najpierw kontakt — potem wszystko inne.

CZAS: 15 min · wypełnij raz, korzystaj wielokrotnie · Najlepiej w spokojnym momencie · z terapeutą

ŹRÓDŁO: Stanley & Brown (2012); Hor & Taylor (2010); Meltzer (2003)

JEŚLI TERAZ JEST CI BARDZO TRUDNO — ZADZWOŃ

116 123 — Telefon Zaufania dla Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym (24/7, bezpłatnie) · **112** — pogotowie ratunkowe · **988** — Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży · **SOR psychiatryczny** w Twoim mieście · **Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)** rejonowe.

Możesz zadzwonić, nawet jeśli nie wiesz, co powiedzieć. Możesz zadzwonić, jeśli nie jesteś pewny/-a, czy „to wystarczająco poważne”. Możesz milczeć przez chwilę. Po drugiej stronie jest człowiek, który chce pomóc.

JAK UŻYWAĆ

Wypełnij **plan bezpieczeństwa Stanleya i Browna** (sekcje 2 i 3) — sprawdzone narzędzie pomagające w trudnych chwilach. Zapisz **swoje wczesne sygnały i konkretne osoby do kontaktu**. Nie czytaj tej karty pierwszy raz w kryzysie — czytaj *teraz*, gdy jest spokojnie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Hor & Taylor (2010, przegląd badań): suicydalność w psychozie jest realnym i niedoszacowanym ryzykiem — wymaga otwartej rozmowy, planu i wsparcia. Niektóre okresy są *szczególnie wrażliwe*: **pierwsze 4 tygodnie po wypisie ze szpitala**, moment **powracającego wglądu** w przebieg choroby (paradoksalnie, gdy umysł się oczyszcza), **depresja po-psychotyczna**. Stanley & Brown (2012, RCT) opracowali *Safety Planning Intervention* — krótka, ustrukturyzowana interwencja, która **znacząco redukuje ryzyko**. Meltzer i in. (2003, badanie InterSePT): **klozapina redukuje ryzyko samobójstwa o około 25%** u pacjentów z opornością na inne leki — warto omówić z psychiatrą.

01 = Kiedy bądź szczególnie czujny/-a

PIERWSZE 4 TYG. PO WYPISIE

Najwyższe ryzyko. Po hospitalizacji potrzebujesz intensywnego wsparcia. Zaplanuj wizytę kontrolną w *pierwszym tygodniu*.

PARADOKS WGLĄDU

Gdy zaczynasz rozumieć, *co się działo* — może przyjść rozpacz. To **znak wsparcia**, nie samotności. Powiedz terapeutce.

DEPRESJA PO-PSYCHOTYCZNA

Po ustąpieniu psychozy bywa fala obniżonego nastroju. To rozpoznawalny, leczalny stan. Powiedz psychiatrze — jest co zrobić.

PO STRACIE · SAMOTNOŚCI

Strata bliskiego, rozstanie, utrata pracy. Społeczne wycofanie. Używanie substancji. *Skumulowane stresory* podnoszą ryzyko.

Ważne: jeśli słyszysz głos nakazujący Ci zrobienie krzywdy sobie lub komuś — **nie wykonuj polecenia**. Eksperymenty z głosami pokazują, że niewykonanie nakazu praktycznie nigdy nie prowadzi do zapowiadanej kary. Zadzwoń pod 116 123 lub do psychiatry. Głos nie ma realnej władzy.

02 Plan bezpieczeństwa — Stanley & Brown

Krótki, sprawdzony plan. **Wypełnij go w spokojnym momencie** — kryzys to zły czas na pisanie. Trzymaj kartę w widocznym miejscu lub w portfelu.

1 · MOJE WCZESNE SYGNAŁY

— co się dzieje, gdy zaczyna być trudno: myśli, emocje, zachowania

2 · CO MOGĘ ZROBIĆ SAMI-A

— co mnie uspokaja (oddychanie, muzyka, spacer, kąpiel, ćwiczenie 5-4-3-2-1)

3 · LUDZIE, KTÓRZY ODWRÓCĄ UWAGĘ

— do kogo mogę zadzwonić bez mówienia o trudnym; po prostu pogadać

4 · BLISCY, KTÓRZY MOGĄ REALNIE POMÓC

— imię, telefon; osoby, z którymi mogę szczerze porozmawiać o tym, co przeżywam

03 5 · Profesjonalne wsparcie + 6 · Bezpieczne środowisko

5 · MÓJ PSYCHIATRA / TERAPEUTA

— imię, telefon, godziny dostępności; numer dyżuru pozagodzinowego, jeśli ma

6 · CO ZROBIĘ, BY ŚRODOWISKO BYŁO BEZPIECZNE

— omów to z bliską osobą lub terapeutą; razem zaplanujcie konkrety

Jeśli plan zawodzi i jest naprawdę źle: 116 123 (24/7) lub 112 · jedź na **SOR psychiatryczny** · poproś zaufaną osobę o towarzyszenie · daj komuś bliskiemu klucze i poproś, by przyszedł. Nie zostawaj sam/-a. *Nie musisz tłumaczyć dlaczego* — wystarczy: „potrzebuję pomocy”.

Klucz: Stanley & Brown (2018, RCT z 1640 pacjentami w 9 SOR-ach w USA): wypełnienie planu bezpieczeństwa po wypisie ze szpitala **redukowało liczbę zachowań samobójczych o 45%** w ciągu 6 miesięcy. To jedna z *najsilniejszych* interwencji w psychiatrii, a zajmuje 20 minut. Meltzer i in. (2003, InterSePT): kłozapina jest **jedynym lekiem** z udowodnionym efektem redukcji ryzyka samobójstwa w schizofrenii — warto omówić z psychiatrą, jeśli inne leki nie dają poprawy. **Najtrudniejsze chwile mijają.** Wgląd, depresja po-psychotyczna, pierwsze tygodnie po wypisie — to *okresy*, nie stany trwałe. Wsparcie w tych okresach robi różnicę. Zadzwonienie pod telefon zaufania nie jest porażką — jest *aktem mądrości*. Jesteś ważny/-a. Twoje życie ma wartość, nawet jeśli teraz tego nie czujesz.